

Modelo — Discussão médico-legal com raciocínio G2i

Uso: adaptar este bloco em laudos periciais psiquiátricos para deixar explícita a passagem entre evidência científica geral e conclusão individual.

Modelo completo

Discussão médico-legal

A análise pericial psiquiátrica exige distinção entre o conhecimento científico geral e sua aplicação ao caso individual. A literatura médica pode demonstrar que determinados transtornos, sintomas ou fatores psicossociais se associam, em nível populacional, a prejuízo funcional, sofrimento psíquico, risco, incapacidade, alteração da capacidade decisória ou outros desfechos médico-legais. Contudo, essa associação geral não autoriza, por si só, conclusão automática sobre um indivíduo específico.

No presente caso, a avaliação deve considerar a passagem da evidência geral para a situação concreta do periciando, isto é, a inferência grupo-para-indivíduo. Para tanto, foram analisados os elementos individualizantes disponíveis, incluindo: entrevista pericial, exame do estado mental, histórico clínico, documentação médica, evolução temporal, tratamentos realizados, resposta terapêutica, funcionalidade descrita e observada, além da coerência entre relato, documentos e achados periciais.

Do ponto de vista psiquiátrico, [INSERIR DIAGNÓSTICO/QUADRO CLÍNICO] pode, em determinadas circunstâncias, associar-se a [INCAPACIDADE LABORAL / PREJUÍZO FUNCIONAL / DANO PSÍQUICO / ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE CIVIL / RISCO / OUTRO DESFECHO]. Essa possibilidade, entretanto, depende da intensidade dos sintomas,

duração, repercussão funcional, contexto clínico, fatores concorrentes, temporalidade e exigências específicas da questão pericial.

No caso concreto, observou-se que [DESCREVER ACHADOS PRINCIPAIS DO EXAME MENTAL E DA ENTREVISTA]. A documentação analisada indica [DESCREVER DOCUMENTOS RELEVANTES]. Quanto à evolução temporal, verifica-se [DESCREVER TEMPORALIDADE]. Em relação à funcionalidade, há elementos de [PRESERVAÇÃO / COMPROMETIMENTO / COMPROMETIMENTO PARCIAL / INSUFICIÊNCIA DE DADOS], especialmente quanto a [DESCREVER ATIVIDADES, FUNÇÕES OU ATOS RELEVANTES].

Assim, a correspondência entre a evidência científica geral e os elementos individualizantes deste caso é [SUFICIENTE / PARCIAL / INSUFICIENTE]. Essa conclusão decorre de [EXPLICAR A PONTE INFERENCIAL: por que os dados do caso confirmam, limitam ou não confirmam a hipótese pericial].

Dessa forma, considerando o conjunto dos elementos analisados, há/não há elementos técnico-periciais suficientes para concluir por [CONCLUSÃO PERICIAL], nos limites acima descritos. Ressalta-se que a conclusão não se baseia exclusivamente na presença de diagnóstico psiquiátrico, mas na integração entre quadro clínico, documentação, evolução, funcionalidade e pertinência médico-legal da questão examinada.

Versão curta

A literatura psiquiátrica descreve que [CONDIÇÃO] pode associar-se a [DESFECHO]. Contudo, a passagem dessa evidência geral para uma conclusão individual exige análise dos dados concretos do periciando. No presente caso, foram considerados entrevista, exame do estado mental, documentação, evolução temporal, tratamento, funcionalidade e coerência dos achados. A correspondência entre a evidência geral e os elementos individualizantes é [SUFICIENTE / PARCIAL / INSUFICIENTE], pois [JUSTIFICAR]. Assim, há/não há elementos técnico-periciais suficientes para concluir por [CONCLUSÃO].

Versão para incapacidade laboral

A presença de diagnóstico psiquiátrico não implica, isoladamente, incapacidade laboral. Embora [DIAGNÓSTICO] possa associar-se a prejuízo funcional em determinados casos, a conclusão pericial exige análise individualizada da intensidade dos sintomas, duração, resposta ao tratamento, evolução temporal, exame do estado mental e exigências específicas da atividade habitual.

No caso concreto, a atividade de [FUNÇÃO] exige [EXIGÊNCIAS COGNITIVAS/EMOCIONAIS/RELACIONAIS/SEGURANÇA]. Os achados periciais demonstram [ACHADOS]. A documentação indica [DOCUMENTOS]. Considerando a correspondência entre esses elementos e as exigências laborais, conclui-se que há/não há incapacidade laboral no período analisado.

Versão para nexos causal trabalhista

A literatura reconhece que fatores psicossociais ocupacionais podem contribuir para adoecimento mental. Todavia, essa associação populacional não equivale automaticamente à comprovação de nexos causal individual. A conclusão pericial exige análise de temporalidade, intensidade e duração da exposição, plausibilidade clínica, documentação contemporânea, antecedentes psiquiátricos, fatores concorrentes e coerência evolutiva.

No presente caso, os elementos disponíveis indicam [DESCREVER EXPOSIÇÃO], com início em [DATA/PERÍODO], e evolução clínica caracterizada por [DESCREVER EVOLUÇÃO]. Também foram considerados fatores concorrentes, como [ANTECEDENTES/EVENTOS EXTRALABORAIS/COMORBIDADES/USO DE SUBSTÂNCIAS/OUTROS]. Diante disso, a relação entre trabalho e adoecimento é [COMPATÍVEL / PARCIALMENTE COMPATÍVEL / NÃO DEMONSTRADA / INSUFICIENTE PARA CONCLUSÃO], em grau técnico-pericial.

Versão para capacidade civil

O diagnóstico psiquiátrico ou neurocognitivo não determina, por si só, incapacidade civil global. A análise deve recair sobre a capacidade funcional específica do periciando para compreender informações relevantes, apreciar consequências, deliberar de modo racional e expressar vontade consistente em relação aos atos jurídicos discutidos.

No caso concreto, foram observados [ACHADOS COGNITIVOS/PSICÓTICOS/AFETIVOS]. A funcionalidade atual demonstra [DESCREVER FUNCIONALIDADE]. Considerando a complexidade dos atos em análise e os elementos individualizantes disponíveis, conclui-se que há/não há comprometimento relevante da capacidade civil para [ATO/DOMÍNIO ESPECÍFICO], nos limites descritos.

Versão para avaliação de risco

A avaliação de risco em psiquiatria possui natureza probabilística. Fatores descritos na literatura podem aumentar ou reduzir a probabilidade de determinado desfecho em grupos semelhantes, mas não permitem previsão individual com certeza. Assim, a conclusão deve considerar fatores de risco, fatores protetores, contexto atual, horizonte temporal e limitações metodológicas.

No caso concreto, identificam-se como fatores de risco [LISTAR]. Como fatores protetores, observam-se [LISTAR]. Considerando a integração desses elementos, o risco é estimado como [BAIXO / MODERADO / ELEVADO / INDETERMINADO], devendo tal conclusão ser interpretada como estimativa clínica-forense probabilística, e não como previsão categórica.

Checklist rápido antes de finalizar

- ☐ A conclusão não depende apenas do diagnóstico?
- ☐ A literatura geral foi separada dos dados individuais?
- ☐ A funcionalidade foi descrita de forma concreta?
- ☐ A temporalidade foi analisada?
- ☐ Fatores concorrentes foram considerados?
- ☐ A ponte entre ciência geral e indivíduo foi explicada?
- ☐ A linguagem está proporcional ao grau de certeza possível?
- ☐ Há ressalva quando a evidência for apenas probabilística?